

細胞障害性抗がん薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 経口抗がん薬・支持療法薬の服用日と残薬の管理
- ☐ 他院処方・市販薬・サプリを含めた併用薬の確認
- ☐ 服用期間中の電話フォロー(nadir期の発熱・口内炎など)
- ☐ 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ
- ☐ 家庭での曝露対策(粉碎しない・排泄物の扱い)の説明

病院薬剤師

- ☐ レジメン監査・投与量計算(体表面積・腎機能・累積投与量)
- ☐ 前投薬・制吐薬・補液など支持療法の確認
- ☐ 抗がん薬の調製と曝露対策、血管外漏出への対応
- ☐ 外来化学療法室での副作用説明・セルフケア指導
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供

病院と共有する情報

レジメン名・投与日

検査値

副作用のGrade

服用状況・残薬

2 投与量・累積量・臓器機能 — 病院の確認を薬局でも活かす

薬剤	病院で確認する値・上限	理由	保険薬局での活用
カルボプラチン	目標AUCと腎機能(カルバート式:AUC×(GFR+25))	GFRの推定方法で投与量が大きく変わる	処方箋の検査値でクレアチニンの推移を確認
シスプラチン	腎機能(CCr)、補液量、Mg補充	腎障害の予防	尿量・むくみ・水分摂取を聴取、NSAIDsの新規処方に注意
ドキシソビシン	累積投与量 500mg/m ² (他のアントラサイクリン系は換算して通算)	超えると心不全のリスクが上昇	治療歴を通算で把握し、息切れ・むくみを聴取
プレオマイシン	総投与量 300mg(力価)	総量に依存して肺線維症のリスク	乾性咳嗽・息切れを聴取
メトトレキサート(大量療法)	血中濃度、尿pH、ホリナート救援	排泄遅延で重篤な副作用	退院後のNSAIDs・PPIの新規処方に注意
イリノテカン	UGT1A1*6/*28の遺伝子多型	ホモ・複合ヘテロで減量を検討	結果を薬歴に記録し、下痢・発熱の指導を強化

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	イリノテカン UGT1A1阻害	処方薬 アタザナビル(抗HIV薬)	SN-38 ↑ → 骨髄抑制・下痢が重篤化	併用しない。他院処方をお薬手帳で確認
禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・S-FU等)	5-FU濃度 ↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意	メトトレキサート 腎排泄の遅延	処方薬 市販薬 NSAIDs・PPI・ST合剤(市販の解熱鎮痛薬も)	MTX濃度 ↑ → 骨髄抑制・粘膜障害	市販の解熱鎮痛薬の使用も聴取
注意	カペシタビン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR ↑ (出血)・フェニトイン中毒	INR測定を頻度を処方医と確認
注意	イリノテカン CYP3A4誘導	サプリ・食品 セイヨウオトギリソウ含有サプリ	SN-38 ↓ → 効果が減弱	サプリ・健康食品の使用を聴取
注意	シスプラチン 毒性の重複	処方薬 アミノグリコシド系抗菌薬・ループ利尿薬	腎障害・聴覚障害 ↑	他院での抗菌薬・利尿薬の処方を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「髪は2〜3週目から抜け始めることが多いので、ウィッグや帽子を早めに準備しておくとうれしいです」

確認:お薬手帳でレジメン・投与日を確認、他院処方・市販薬・サプリの有無
△ 口腔ケア・歯科受診は治療前に済ませておく

投与当日〜5日

「吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。2〜5日目の吐き気にも備えましょう」

確認:制吐薬の服用状況、水分・食事量(電話フォローで確認)
△ 水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡

投与後1〜2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずにすぐ病院へ。手洗い・うがいもこまめに」

確認:電話フォローでnadir期の発熱・口内炎を確認
△ 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診

次回来局時

「手足のしびれや口内炎、食事の状況はいかがですか。前回と比べて教えてください」

確認:しびれ・口内炎をGradeで記録し、トレーシングレポートで共有
△ Grade2以上は処方医へ情報提供